

Информационный отчёт

05.10.2026, 03:00:00

Поддержка принятия решений. Нема не устанавливает диагноз и не назначает лечение. Результат требует оценки врачом.

ДЕМОНСТРАЦИЯ. Вымышленные анализы. Показан сохранённый расчёт локальной модели и рекомендации для выбранной роли.

Оценка по гемоглобину

Гемоглобин ниже порога анемии.

Hb: 105 г/л. Порог: 120 г/л. Отсутствие анемии по Hb не исключает дефициты.

Предполагаемое состояние

Возможная железодефицитная анемия

Модель допускает: Железо

Что удалось оценить

Hb ниже порога для указанного пола. Этиология анемии не устанавливается по одному Hb; сопоставьте результат с клиникой и остальными исследованиями.

Полнота данных

Панель 35/35 содержит Hb, MCV, MCH и маркеры железа/B12/фолатов. Покрытие не является оценкой калибровки модели.

Оценки модели по дефицитам

Железо: 0.999

Витамин B12: 0.000

Фолаты: 0.007

Витамин B6: 0.007

Медь: 0.002

Оценки модели по видам анемии

Возможная B12-дефицитная анемия: 0.002
Возможный дефицит B12 без анемии: 0.000
Возможный дефицит B6: 0.020
Причина анемии требует уточнения: 0.002
Возможный дефицит меди: 0.002
Возможная фолатодефицитная анемия: 0.001
Возможный дефицит фолатов без анемии: 0.000
Возможная анемия на фоне воспаления: 0.004
Возможная железодефицитная анемия: 0.817
Возможное дефицитное состояние без анемии: 0.005
Возможно сочетание дефицитов: 0.145
Порог анемии не достигнут: 0.001

Следующие шаги

1. Рекомендуется проверить наличие железодефицита по маркерам обмена железа и оценить возможные причины, включая кровопотери и нарушение всасывания, с учётом анамнеза. Обратите внимание на результаты LDH, билирубина, гаптоглобина, ретикулоцитов, RDW, ферритина, TSAT, sTfR и CRP для уточнения причины патологии.
2. Ферритин и CRP доступны; интерпретируйте ферритин с учётом воспалительного контекста, клиники и лабораторных референсов. Рекомендуется оценить ретикулоциты, RDW, sTfR и TSAT; при необходимости — назначить недостающие исследования.
3. Общий или активный B12 и фолаты представлены одновременно. Сопоставьте методы, единицы, даты и сведения о приёме добавок; наличие анализов не подтверждает дефицит.
4. Сопоставьте бланки, даты, симптомы и предшествующую терапию. Состав и сроки повторных исследований определяются индивидуально; пакет разных дат не считается одним моментом обследования.

Ограничения оценки

Полностью вымышленные анализы. Сохранён настоящий расчёт локальной исследовательской модели; это пример работы программы, а не данные пациента.

Модели исследовательские, scores не откалиброваны. Отсутствие анализа не считается нормой.

Оценки модели 0–1 не являются проверенной вероятностью заболевания. Низкие значения не исключают дефицит.

Часть текстов уточнена медицинской командой. Каталоги и правила достаточности остаются черновиком; клиническая валидация не выполнена.

Исходные показатели

Возраст: 42. Пол: женский. Пустой показатель не считается нормальным.

Гемоглобин: 105 г/л

Эритроциты: $4.3 \times 10^{12}/\text{л}$

Объём эритроцита: 72 фл

Гемоглобин в эритроците: 24 пг

Гематокрит: 31 %

Распределение эритроцитов: 18 %

Ферритин: 6 мкг/л

Сывороточное железо: 4 мкмоль/л

Витамин B₁₂: 450 пг/мл

Фолаты: 10 нг/мл

Концентрация Hb: 339 г/л

Тромбоциты: $250 \times 10^9/\text{л}$

Лейкоциты: $6 \times 10^9/\text{л}$

Ретикулоциты: 1 %

Трансферрин: 3.8 г/л

ОЖСС: 80 мкмоль/л

НЖСС: 76 мкмоль/л

Насыщение трансферрина: 5 %

Растворимый рецептор трансферрина: 5 мг/л

Hb ретикулоцитов: 22 пг

Активный B₁₂: 80 пмоль/л

Метилмалоновая кислота: 0.15 мкмоль/л

Гомоцистеин: 9 мкмоль/л

Витамин B₆: 45 нмоль/л

Медь: 17 мкмоль/л

Церулоплазмин: 0.25 г/л

С-реактивный белок: 1 мг/л

СОЭ: 8 мм/ч

Креатинин: 70 мкмоль/л
СКФ: 100 мл/мин/1,73 м²
ТТГ: 2 мМЕ/л
Альбумин: 43 г/л
ЛДГ: 180 Ед/л
Непрямой билирубин: 8 мкмоль/л
Гаптоглобин: 1.2 г/л

Происхождение отчёта

Модель: hema-baseline-v1-b413ce1e45d6. Пример: Железо: расширенная панель.
Версия файла фраз: phrases-draft-1.2. ID отчёта: локальный.